

УДК 616-006.61

Н.С. Карамян

Национальный центр онкологии МЗ Республики Армения им. В. А. Фанарджяна

Результаты лечения больных плоскоклеточным раком верхнего отдела воздушно-пищеварительного тракта

Аннотация. Целью исследования является поиск способов повышения эффективности лечения больных плоскоклеточным раком головы и шеи (ПРГШ) в условиях развивающихся стран.

Материалом для данного исследования послужили результаты проведенного в Национальном Центре Онкологии Армении лечения больных ПРГШ с 2000 по 2009 годы.

Проведен ретроспективный анализ показателей выживаемости 1235 первично выявленных больных ПРГШ, локализованном в различных отделах глотки, полости носа и околоносовых пазухах, полости рта и в гортани. Показаны результаты лечения в Армении в зависимости от примененного метода, стадии заболевания и других факторов, влияющих на показатели выживаемости.

Ключевые слова: голова и шея, плоскоклеточный рак, радиотерапия

Введение

Согласно опубликованным Международным агентством по исследованию рака данным (IARC), заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) в мире превысит отметку 21 миллионов случаев к 2030 году, причем две трети из них будет приходиться на развивающиеся страны. Поэтому, страны, на которые придется основное бремя заболеваемости, уже сейчас должны начать готовиться для противостояния этому "нашествию". Для стран с недостаточным финансированием здравоохранения надеяться на быстрое внедрение современных технологий, с целью массового улучшения ранней диагностики и лечения, проведения скрининговых программ и т.д., не всегда реально. Выявление и устранение факторов, в том числе организационных, снижающих показатели выживаемости (ПВ), будет способствовать продлению комфортной жизни пациентов без существенного увеличения бюджета, выделенного на лечение больного.

Частота заболеваемости плоскоклеточным раком головы и шеи (ПРГШ) в мире за последние два десятилетия относительно стабильно стабилизировалась. ,+

Доказано различие ПВ между развитыми странами и странами развивающимися, где заболеваемость продолжает расти [1]. Лечение больных ПРГШ требует применения всех имеющихся в арсенале медицины доступных средств. К сожалению, более 70% больных в Армении на момент установления диагноза находятся в запущенной стадии заболевания, что заведомо снижает эффективность проводимого лечения. Ведение этих больных осложняется тягостной симптоматикой,

сопровождаящей течение заболевания, нередко, тяжелыми последствиями проведенного лечения, значительно снижающими качество жизни.

Частота назначения радиотерапии (РТ) на одном из этапов лечения ПРГШ в развитых странах достигает 70 – 90%, что подтверждает неоспоримость значимости РТ и отсутствие эффективной альтернативы этому методу лечения [2,3]. Несмотря на значительное усовершенствование технических средств и методов облучения за последние 3 десятилетия, для РТ остаются ограничения, связанные, в основном, с лимитацией максимально допустимой дозы облучения. Подведение высоких опухолецидных доз сопряжено с опасностью развития у больных острых и поздних лучевых повреждений, что отражается на качестве и продолжительности их жизни [4,5].

Проведенные за последние годы исследования выявили значительное улучшение результатов лечения при сочетании РТ с химиотерапией (ХТ), применяемой одновременно, синхронно с использованием локально-пространственной кооперации независимых агентов для потенцирования действия ионизирующего излучения [6].

Обзор литературных данных подтверждает тенденцию к проведению при ПРГШ органосохранного лечения, с обеспечением хороших результатов отдаленной выживаемости и максимальным сохранением качества жизни таких больных. Важное значение имеют: усовершенствование техники органосохранных операций с применением реконструктивных технологий; выбор оптимальных режимов фракционирования дозы при облучении различных локализаций ЗН; синхронное проведение РТ и ХТ; использование различных предиктивных факторов [7,8] для корректной оптимизации алгоритма лечения и оценки ожидаемой эффективности запланированного лечения.

Одной из нерешенных задач является проблема возникновения и лечения мукозитов в динамике РТ и ХТ. По данным Т. Сонис [9], опубликованным в 2004 году, от осложнений мукозитов в США ежегодно умирают от 6 до 30% больных со ЗН. Помимо этого удручающего факта, развитие мукозитов приводит к вынужденному прерыванию курса лечения, к увеличению его стоимости, к снижению суммарной очаговой дозы РТ и курсовой дозы ХТ, что негативно сказывается на эффективности лечения. Применение новых высокотехнологичных методов РТ, разработка и применение новых, весьма дорогих радиопротекторных соединений позволило снизить частоту и степень поздних повреждающих проявлений облучения на спинной мозг, слюнные железы и т.д., но на проблему лечения острых мукозитов они не оказали радикального влияния.

Целью исследования является определение основных причин неудач в лечении ПРГШ, выявление наиболее

эффективного метода лечения, из применяемых в Армении, при различных локализациях ЗН в верхних отделах воздушно-пищеварительного тракта, изыскание резервных возможностей повышения эффективности лечения.

Характеристика исследованных больных, методов исследования и лечения

Из числа первично выявленных 1235 больных, хирургическое лечение (ХЛ) в качестве самостоятельного и комбинированного/комплексного метода лечения было проведено в 429 (34,7%) случаях.

Куративный курс РТ получили 569 (46,1%) больных. Комплексное лечение с применением всех трех основных методов получили 225 пациентов, в том числе, модифицированное нами синхронное химиолучевое лечение (СХЛЛ) проведено у 100 (8,1%). Сущность модификации заключается в синхронном назначении в последние 3 недели курса РТ цисплатины, используя ее радиопотенцирующие свойства. ХТ в качестве единственного метода лечения получили лишь 12 (0,97%) больных.

Облучение проводилось на кобальтовых машинах в стандартном и разработанном нами эскалационном режиме фракционирования дозы, который отличался от стандартного пошаговым повышением разовой очаговой дозы с 1,8 Гр до 2,5-3 Гр. Помимо общепринятых методов лечения мукозитов и дерматитов мы использовали предложенные нами сборы лекарственных растений, на что получены авторские свидетельства.

Для получения статистических данных пользовались актуарийным расчетом по методу Каплан-Мейера. Ниже приводится распределение больных по стадиям в зависимости от локализации опухоли (таблица 1).

Всего 5,5% больных было выявлено в I и почти 74% в III-IV стадиях заболевания, что свидетельствует о нерешенных вопросах скрининга, ранней диагностики и труднодоступности квалифицированной медицинской

Таблица 1- Распределение больных по стадиям в зависимости от локализации опухоли

Локализация/стадия	I	II	III	IV	Всего
“Верхний” этаж	3 (1,4%)	16(7,3%)	113(51,4%)	88(40%)	220(17,8%)
“Средний” этаж	13 (5,3%)	37(15,1%)	116(47,3%)	79(32,2%)	245(19,8%)
“Нижний” этаж	52(6,75%)	201(26,1%)	346 (44,9%)	171(22,2%)	770(62,3%)
Всего	68 (5,5%)	254(20,56%)	575(46,55%)	338(27,4%)	1235

Примечание: *- В группе “верхнего” этажа рекрутированы больные с локализацией ЗН в носоглотке, полости носа и параназальных синусах. В группу “среднего” этажа рекрутированы больные с локализацией опухоли в ротовой полости и ротоглотке. В группу “нижнего” этажа вовлечены больные со ЗН гортани и гортаноглотки

помощи в РА, что и является основной причиной неудач в лечении больных ПРГШ.

Полученные результаты и их обсуждение

Нами предпринята попытка показать влияние некоторых факторов, независимых от лечебного процесса, на показатели выживаемости. Исходя из сказанного мы определили ПВ исходя из этажности локализации ЗН (таблица 2).

Полученные данные свидетельствуют о различиях ПВ в зависимости от “этажа” локализации опухоли. При этом, наибольшее количество больных (90%) с меснораспространенным процессом (III и IV стадии) зарегистрировано в группе больных с локализацией опухоли в “верхнем” этаже и наименьшее количество (67%) в аналогичных стадиях зарегистрировано у больных “нижнего” этажа, а среди больных “среднего” этажа таковых было 80%. Однако, наихудшими оказались ПВ при локализации опухоли в “среднем” этаже, что свидетельствует о влиянии и других факторов на ПВ, помимо стадийности (таблица 3).

Таблица 3- Изменения возрастных и гендерных показателей в зависимости от локализации опухоли

Локализация опухоли	Медиана возраста всей группы	Медиана возраста группы получивших РТ	Гендерное соотношение м/ж
“Верхний” этаж	54,5	63	2,8/1
“Средний” этаж	60	64	3,6/1
“Нижний” этаж	62	66	37,5/1

Показанные данные свидетельствуют о выраженной разнице соотношения мужчин/женщин и медианы возраста в зависимости от этажа локализации опухоли. После изучения опубликованных в Globocan данных по другим странам, такой большой разницы в соотношении м/ж при ЗН “нижнего” этажа мы не обнаружили. Соотношение 37,5/1 увеличивается до 40/1 у подгруппы больных раком гортани, которым была назначена РТ. Необходимо отметить значительно лучшие ПВ у женщин. При всех локализациях и методах лечения ПВ были более предпочтительны у пациентов более молодого возраста, за исключением больных с локализацией опухоли в “нижнем” этаже, получивших РТ. Необходимо отметить, что во всех подгруппах медиана возраста пациентов, получивших РТ, на 4-8 лет превосходила медиану возраста больных, получивших другие методы лечения. На наш взгляд, данный факт обусловлен отбором хирургами более сохранных больных.

Опухоли различных локализаций, в том числе, локализованные на одном этаже, по разному отвечали

Таблица 2- Показатели общей выживаемости больных ПРГШ в зависимости от “этажности” локализации опухоли

ПВ	“Верхний” этаж	“Средний” этаж	“Нижний” этаж
Численность больных	220	245	770
Количество выживших	110 (50%)	100 (40,82%)	420 (54,55%)
Количество умерших	110	145	350
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в месяцах	57,0*	47,7*	65,8*
Стандартная ошибка	3,7	3,4	2,1
Медиана жизни в месяцах	30,7	19,1	55,2
95% доверительный интервал	49,7 – 64,3	40,9 – 54,4	61,7 – 69,8
Лимитированное время наблюдения в месяцах	117,7	117,8	121,7

Примечание: *- разность статистически достоверна

на примененные комбинации основных методов лечения (таблица 4).

Таблица 4 - Процент выживших больных по локализациям и примененным методам лечения

Выжившие/метод	ХЛ	Комбинированное	РТ	СХЛЛ	Компл-ексное
Носоглотка	-	72,7	44,2	77,4	26,7
Полость носа	-	61,5	50,0	66,7	29,4
Ротовая полость	-	72,2	27,1	50,0	7,1
Ротоглотка	-	63,6	45,9	56,2	23,5
Гортань	73,6	74,4	40,4	42,4	38,5
Гортаноглотка	46,1	58,3	46,1	50,0	42,9

Примечание: *ХЛ – хирургическое лечение, Комбинированное – хирургия в комбинации с РТ, РТ – только радиотерапия, СХЛЛ – параллельная РТ-ХТ, Комплексное – назначение ХТ на одном из этапов лечения*при локализации ЗН в “верхнем” и “среднем” этажах хирургические вмешательства были в количестве от 1 до 3, поэтому их показатели не учтены.

Процент выживших после СХЛЛ значительно превышал ПВ по сравнению с комплексным лечением и РТ по всем локализациям ЗН. Необходимо отметить, что от 70 до 90% больных, получивших РТ, находились в III-IV стадиях заболевания. В тех же стадиях регистрировались 75-95% больных, получивших СХЛЛ. Более высокие ПВ в подгруппе получивших СХЛЛ наблюдались по сравнению с комбинированным лечением ЗН “верхнего” этажа. Несмотря на то, что частота и выраженность острых лучевых повреждений была наибольшей в динамике СХЛЛ, однако эти повреждения эффективно и быстро (2-5 дней) излечивались при использовании предложенной нами смеси лекарственных растений. Необходимо отметить, что себестоимость предложенной смеси за курс лечения не превышает 20USD. Помимо изложенного, после СХЛЛ отмечено наименьшее количество рецидивов, по сравнению с остальными методами лечения. Приведенные данные комбинированного и синхронного химиолучевого лечения еще раз свидетельствуют о необходимости мультимодального лечения больных ПРГШ, с расширением активности ХЛ, особенно, при локализациях опухоли в “верхнем” и “среднем” этажах головы и шеи.

Понятно, что эффективным путем снижения смертности, продления комфортной жизни больных ПРГШ, повышения эффективности лечения с соблюдением всех требований гарантии качества лечебного процесса возможно при решении вопросов массового внедрения скрининговых программ, ранней и доступной диагностики, приобретения и внедрения новейших технологий и т.д. Однако, больные не могут ждать улучшения экономической ситуации в странах с недостаточным финансированием здравоохранения, т.к. им уже сейчас требуется квалифицированная медицинская помощь.

Помимо, приведенных данных, нами было изучено также влияние многих других факторов, оказывающих воздействие на показатели выживаемости при лечении ПРГШ. К их числу относятся: предшествующая РТ трахеостомия; примененный режим фракционирования; отклонения от запланированного графика облучения; гендерное и возрастное различие ПВ, проявляющееся по-разному в зависимости от локализации ЗН; отсутствие медикаментозной и предлучевой санации

полости рта для профилактики лучевых повреждений и предотвращения вынужденных перерывов в лечении, каждый день которых снижает эффективность РТ на 1-1,5% [10]; отхождение от общепринятых протоколов лечения внепрофильных клиник и т.д. Все приведенные факторы поддаются коррекции, что будет способствовать продлению комфортной жизни пациента.

Другим важным вопросом, касающимся оценки эффективности применяемых методов лечения, является законодательное внедрение эпидемиологического показателя скорректированной безрецидивной выживаемости в Армении. Внедрение указанного показателя, а также фармакоэкономического показателя “полезность – затраты”, подтолкнет руководителей здравоохранения к пониманию и решению проблем достойного финансирования радиационной онкологии в странах с недостаточным финансированием.

Список литературы

1. Globocan 2012, by courtesy of D. M. Parkin, IARC, Lyon.
2. Ding M., Newman N., Raben D. New radiation therapy techniques for the treatment of head and neck cancer // *Otolaryngol. Clin. North. Am.* – 2005. – Vol. 38, N2. P. 371-395.
3. Карамян Н.С.. Возможности радиотерапии плоскоклеточного рака головы и шеи в развивающихся странах // VII съезд онкологов и радиологов стран СНГ.–Астана, 2012 - №160.
4. Vissink K., Jansma J., Spijkervet F.K. et al. Oral sequelae of Head and Neck radiotherapy // *Crit. Rev. Oral. Biol. Med.* – 2003. – Vol. 14, N3. – P. 199 – 212.
5. Bourhis J., Tesson A., Lusinchi A. New trends in radiotherapy for head and neck cancer // *Ann. Oncol.* – 2005. – Vol. 16 Suppl 2 – P.255-257.
6. Bernier J., Dromme C., Eschwege F. et al. Chemo-radiotherapy, as compared to radiotherapy alone significantly increases disease-free and overall survival in head and neck cancer patients after surgery: Results of the EORTC Phase III trial 22931 // *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* – 2001. – Vol. 51. – P.1.
7. Bourhis J., Audry H., Overgaard J. et al. Meta-analysis of Conventional Versus Altered Fractionated Radiotherapy in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC): Final Analysis // 46-th Annual Meeting of the American Society for Therapeutic Radiology and Oncology, Atlanta, Georgia – October 3 – 7, 2004 – Scientific Abstracts – N100.
8. Harari P.M. Promising new advances in head and neck radiotherapy // *Ann. Oncol.* – 2005. – Vol. 16, Suppl 6 – P. vi13 – vi19.
9. Sonis S.T., Elting L.S., Keefe D. et al. Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury: pathogenesis, measurement, epidemiology, and consequences for patients // *Cancer.* – 2004. – Vol. 100. – P.1995-2025.
10. Fowler J.F., Lindstrom M.J.. Loss of local control with prolongation in radiotherapy // *Int. J. Radiat. Biol. Oncol. Phys.* – 1992.-Vol. 23. – P. 457 – 463.

Тұжырым

Н.С.Карамян

В. А. Фанарджяна атындағы Армен Ұлттық Онкологиялық Орталығы

Ас қорыту жүйесі жоғарғы бөлігінің жалпақ жасушалы қатерлі ісіктерінің емдеу нәтижелері.

Зерттеудің мақсаты дамушы елдердегі Бас және мойын жалпақ жасушалы қатерлі ісік (БМЖҚ) науқастарының емдік нәтижелерін жоғарлату тәсілдерін іздестіру. Зерттеу мағлұматтары Армен Ұлттық Онкологиялық Орталығының 2000-2009 жылдар аралығындағы БМЖҚ науқастарының емдік нәтижелерінен алынған. Алғаш анықталған 1235 БМЖҚ әр-түрлі аймақта орналасқан, жұтқыншақ, мұрын және мұрынайналасы қуыстары, тамақ және ауыз

қуысы науқастарының өміршендік көрсеткіштеріне ретроспективті қортынды жүргізілген. Армениядағы өміршендік көрсеткіштеріне әсер ететін, емдеу тәсілі, ауру кезеңі және басқа себептер емдеу нәтижелерінің қортындылары көрсетілген.

Түйінді сөздер: бас және мойын, жалпақ жасушалы ісік, радиотерапия.

Summary

N. S. Karamyan

National Centre of Oncology, Dept. of Radiation Oncology

Results of treatment of patients with squamous cell

carcinoma localized in upper parts of aero-digestive tracts

The aim of this study is to find ways to improve the treatment of patients with squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN) in the context of developing countries. Material for this study is based on the results of the treatment of patients with SCCHN treated in the Armenian National Centre of Oncology from 2000 to 2009. A retrospective analysis of survival in 1235 initially diagnosed patients with SCCHN, localized in different parts of the pharynx, nasal cavity and paranasal sinuses, oral cavity and larynx. The results of treatment in Armenia are shown, depending on the method applied, the stage of disease and other factors affecting survival.

Key-words: Head and neck, squamous cell carcinoma, radiotherapy.